ANA MATERYAL

# 12 Haftalık Rotasyon Çalışma Programı

Günde 30–45 dakika, haftada altı gün. Fizikten çoklu modalite vakalarına kadar her hafta tek bir hedef, beş vaka ve kısa bir öz değerlendirme; her rotasyona ve her vizite hazır gelmeniz için.

# İçindekiler


Bu program nasıl kullanılır

İkinci dönemde tekrar

Hafta 1 · Fiziksel alfabe ve terminoloji

Hafta 2 · Akciğer grafisi

Hafta 3 · Batın ve kas-iskelet grafileri

Hafta 4 · Beyin BT

Hafta 5 · Toraks BT

Hafta 6 · Batın BT

Hafta 7 · Beyin ve omurga MR

Hafta 8 · Kas-iskelet ve batın MR

Hafta 9 · Batın ve yüzeyel USG

Hafta 10 · Doppler ve POCUS

Hafta 11 · Çoklu modalite ve acil

Hafta 12 · Genel tekrar ve vizit simülasyonu

Sonraki adım

BAŞLARKEN

# Bu program nasıl kullanılır

Yoğun nöbet haftalarında bile sürdürülebilecek kadar kısa, bir yılı taşıyacak kadar düzenli.

> *Asistanlıkta fark yaratan şey tek bir uzun çalışma gecesi değil, her gün aynı saatte yapılan kısa ve düzenli tekrardır.*

## Haftanın ritmi

| GÜN | SÜRE | NE YAPARSINIZ |
|---|---|---|
| Pazartesi–Cuma | 30–45 dk | Günün konusu: ilgili cildi okuyun, atlasta karşılığını görün, vakalardan birini çözün. |
| Cumartesi | 30–45 dk | Haftanın kalan vakaları ve hafta sonu öz değerlendirmesi. |
| Pazar | — | Dinlenme. Hafta içinde nöbet nedeniyle kaçırdığınız bir gün varsa telafi günü olarak kullanın. |

## Her vakada aynı 4 adım

1. **HAZIRLA** — Belirleyin (hasta, tetkik, tarih, protokol), kaliteyi kontrol edin (teknik yeterlilik), yönlenin (taraf, kesit, pencere veya sekans).
2. **TARA** — Her bölgeyi her seferinde aynı sırayla tarayın. İlk bulguda durmayın.
3. **TANIMLA** — Doğru terimle (dansite / sinyal / ekojenite), lokalizasyon, boyut ve sınırla tanımlayın; eski tetkik ve kontralateral tarafla karşılaştırın.
4. **ÖZETLE** — Bir sonuç cümlesi, ayırıcı tanı ve öneri yazın. Acil bulgu varsa bildirmeyi unutmayın.

> **Pratik Defteri'ni yanınızda tutun**
>
> Her vakanın sonunda Pratik Defteri'ne üç satır yazın: ne gördünüz, hangi terimi kullandınız, sonuç cümleniz ne. Haftanın sonunda bu satırlar en değerli tekrar notunuz olur.

## Programı rotasyonunuza uyarlayın

- Haftaların sırası bir öneridir. Şu an nöro rotasyonundaysanız Hafta 4 ve Hafta 7'yi öne alabilirsiniz; diğer haftalar kendi sırasıyla devam eder.

- Vakalar zorluk sırasına göre ilerler. Haftaların sırasını değiştirseniz bile her haftanın beş vakasını o haftayla birlikte çözün.
- Nöbet ertesi günlerde süreyi 30 dakikaya indirin, programı bırakmayın. Kısa ama düzenli çalışma, uzun ama düzensiz çalışmadan daha kalıcıdır.
- İlerlemenizi Haftalık İlerleme Takip Kâğıdı'na işaretleyin.

YILIN İKİNCİ YARISI

# İkinci dönemde tekrar

12 haftayı bitirdiğinizde döngüyü yeniden başlatın; ikinci tur daha hızlı ve daha seçici olur.

1. **Daha hızlı ikinci geçiş.** Okuma bölümlerini kısaltın; asıl zamanı vakalara ve kendi raporlarınıza ayırın.
2. **Önce çözemediklerinizi çözün.** Takip kâğıdında işaretlemediğiniz veya zorlandığınız vakaları her haftanın başına alın.
3. **Süre tutun.** Her vakayı cevaba bakmadan önce kronometreyle çözün ve süreyi not edin. Amaç acele etmek değil, sabit sıranın otomatikleşmesidir.
4. **Sırayı rotasyona göre değiştirin.** Yılın ikinci yarısında hangi rotasyondaysanız ilgili haftaları öne alın.
5. **Atlanmış vakaları ekleyin.** İlk turda programa girmeyen 100 Pratik Vaka numaralarını ikinci turda haftalara dağıtın; böylece yılın sonunda yüz vakanın tamamını çözmüş olursunuz.
6. **Sesli sunun.** Her vakayı vizitte sunar gibi 60 saniyede yüksek sesle özetleyin.

> **İkinci turun ölçütü**
>
> Aynı vakayı ilk turdan daha kısa sürede, daha az eksikle ve daha net bir sonuç cümlesiyle anlatabiliyorsanız doğru yoldasınız.

HAFTA 1

# Fiziksel alfabe ve terminoloji

Görüntünün nasıl oluştuğunu ve onu hangi kelimelerle anlatacağınızı oturtun.

**Haftanın hedefi**

Röntgen, BT, MR ve USG'de parlaklığın neden oluştuğunu açıklayabilmek ve her modalitede doğru terimi (opasite, dansite, sinyal, ekojenite) kullanmak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Röntgen ve BT görüntü oluşumu; zayıflama ve HU kavramı. | Cilt 01 · Fiziksel Alfabe |
| **Sal** | 30–45 dk | MR temelleri: T1, T2, FLAIR ve DAG'ın genel mantığı. | Cilt 01 · Fiziksel Alfabe |
| **Çar** | 30–45 dk | USG temelleri: ekojenite, akustik gölge, arka akustik güçlenme. | Cilt 01 · Fiziksel Alfabe |
| **Per** | 30–45 dk | Modaliteye göre terimler ve kısaltmalar; sık karıştırılanlar. | Görüntünün Alfabesi |
| **Cum** | 30–45 dk | 4 adımlı metodun okunması; Vaka 1–3. | Görüntü Yorumlama Rehberi · 100 Pratik Vaka |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 4–5 ve öz değerlendirme; terimleri deftere yazın. | 100 Pratik Vaka · Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 1 · Vaka 2 · Vaka 3 · Vaka 4 · Vaka 5

### Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Hava, yağ, yumuşak doku, kemik ve metalin röntgende ve BT'de neden farklı göründüğünü açıklayabiliyorum.
- [ ] Hiperdens, hiperintens ve hiperekoik terimlerini doğru modaliteyle eşleştirebiliyorum.
- [ ] T1 ve T2 ağırlıklı görüntüde sıvının nasıl göründüğünü söyleyebiliyorum.
- [ ] Akustik gölgenin neyi düşündürdüğünü ve bir örneğini verebiliyorum.
- [ ] 4 adımı (HAZIRLA · TARA · TANIMLA · ÖZETLE) ezbere ve sırasıyla sayabiliyorum.

HAFTA 2

# Akciğer grafisi

Nöbette en sık önünüze gelecek tetkik için sabit bir okuma sırası.

**Haftanın hedefi**

PA ve yatak başı akciğer grafisini her seferinde aynı sırayla okumak; pnömotoraks, efüzyon, konsolidasyon ve tüp-kateter pozisyonunu atlamamak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Teknik kalite (rotasyon, inspiryum, penetrasyon) ve normal anatomi. | Cilt 02 · Röntgen |
| **Sal** | 30–45 dk | Sabit tarama sırası; Vaka 9. | Cilt 02 · Röntgen · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Konsolidasyon, atelektazi, efüzyon; atlasta karşılaştırın. Vaka 10. | En Sık Bulgular Atlası |
| **Per** | 30–45 dk | Pnömotoraks, kardiyomegali, pulmoner ödem. Vaka 11. | Cilt 02 · En Sık Bulgular Atlası |
| **Cum** | 30–45 dk | Tüp, kateter ve dren pozisyonları; Vaka 12. | Cilt 02 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 13, öz değerlendirme, akciğer grafisi rapor kalıbı. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 9 · Vaka 10 · Vaka 11 · Vaka 12 · Vaka 13

### Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Bir akciğer grafisinde teknik yeterliliği üç başlıkta değerlendirebiliyorum.
- [ ] Tarama sıramı kâğıda bakmadan söyleyebiliyorum.
- [ ] Konsolidasyon ile atelektaziyi ayıran bulguları sayabiliyorum.
- [ ] Pnömotoraksta aranacak plevral çizgiyi ve gerilim bulgularını tarif edebiliyorum.
- [ ] Endotrakeal tüp ve santral kateter ucunun kontrolünü sırama ekledim.

HAFTA 3

# Batın ve kas-iskelet grafileri

Direkt batın grafisi ve kırık değerlendirmesinde gözden kaçanları yakalamak.

**Haftanın hedefi**

Serbest hava ve obstrüksiyon bulgularını tanımak; kırığı yer, tip ve deplasmanla tanımlamak ve iki projeksiyon kuralını uygulamak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Direkt batın grafisinde sabit sıra: gaz dağılımı, serbest hava, kalsifikasyonlar. | Cilt 02 · Röntgen |
| **Sal** | 30–45 dk | İnce ve kalın barsak obstrüksiyonu, volvulus; Vaka 18. | En Sık Bulgular Atlası · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Kırık tanımlamanın dili; üst ekstremite. Vaka 19. | Cilt 02 · Görüntünün Alfabesi |
| **Per** | 30–45 dk | Alt ekstremite, kalça, çıkıklar; Vaka 20. | Cilt 02 · En Sık Bulgular Atlası |
| **Cum** | 30–45 dk | Pediatrik kırıklar ve yabancı cisim; Vaka 21. | Cilt 02 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 22, öz değerlendirme, kırık rapor cümleleri. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 18 · Vaka 19 · Vaka 20 · Vaka 21 · Vaka 22

## Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Diyafram altı serbest havayı ve hangi pozisyonda arandığını açıklayabiliyorum.
- [ ] İnce ve kalın barsak dilatasyonunu ayıran görünümleri sayabiliyorum.
- [ ] Bir kırığı kemik, bölge, hat tipi, deplasman ve eklem tutulumuyla tanımlayabiliyorum.
- [ ] Tek projeksiyonla kırık dışlanamayacağını ve neden olduğunu açıklayabiliyorum.
- [ ] Çocukta kırık değerlendirirken büyüme plağını ayrıca kontrol ediyorum.

HAFTA 4

# Beyin BT

Nöbetin en kritik tetkiki: kanama, inme ve kitle etkisini kaçırmamak.

**Haftanın hedefi**

Kontrastsız beyin BT'yi beyin, inme ve kemik pencerelerinde sabit sırayla okumak; kanama tiplerini ve erken iskemi bulgularını tanımak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Pencereler ve normal anatomi; sabit tarama sırası. | Cilt 03 · BT |
| **Sal** | 30–45 dk | Epidural, subdural, subaraknoid ve intraserebral kanama. Vaka 26. | En Sık Bulgular Atlası · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | İskemik inme: erken bulgular, hiperdens arter. Vaka 27. | Cilt 03 · BT |
| **Per** | 30–45 dk | Kitle etkisi, orta hat şifti, hidrosefali, herniasyon. Vaka 28. | Cilt 03 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cum** | 30–45 dk | Kemik penceresinde kalvaryum ve kafa tabanı; sinüsler. Vaka 29. | Cilt 03 · BT |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 30, öz değerlendirme, beyin BT rapor kalıbı. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 26 · Vaka 27 · Vaka 28 · Vaka 29 · Vaka 30

## Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Epidural ve subdural hematomu şekil ve sınır özellikleriyle ayırt edebiliyorum.
- [ ] Subaraknoid kanamada nerelere bakacağımı sayabiliyorum.
- [ ] Erken iskemi bulgularını ve inme penceresinin neden kullanıldığını açıklayabiliyorum.
- [ ] Kitle etkisini tarif eden bulguları raporda doğru sırayla yazabiliyorum.
- [ ] Kemik penceresini hiçbir beyin BT'de atlamıyorum.

HAFTA 5

# Toraks BT

Akciğer ve mediasten pencerelerinde düzenli okuma; acil toraks tabloları.

**Haftanın hedefi**

Toraks BT'yi akciğer, mediasten ve kemik pencerelerinde okumak; pulmoner emboli, aort diseksiyonu ve pnömotoraks gibi acil bulguları tanımak, nodülü doğru tanımlamak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Pencereler, normal mediasten anatomisi, sabit sıra. | Cilt 03 · BT |
| **Sal** | 30–45 dk | Pulmoner emboli BT anjiyografi: kontrast fazı ve dolum defekti. Vaka 35. | Cilt 03 · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Aort diseksiyonu ve anevrizma. Vaka 36. | En Sık Bulgular Atlası |
| **Per** | 30–45 dk | Nodül, kitle, buzlu cam, amfizem: tanımlama dili. Vaka 37. | Cilt 03 · Görüntünün Alfabesi |
| **Cum** | 30–45 dk | Pnömotoraks, efüzyon, travmada toraks. Vaka 38. | Cilt 03 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 39, öz değerlendirme, toraks BT rapor kalıbı. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 35 · Vaka 36 · Vaka 37 · Vaka 38 · Vaka 39

## Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Pulmoner emboli için tetkikin yeterli kontrastlanıp kontrastlanmadığını kontrol ediyorum.
- [ ] Aort diseksiyonunda flebin ve tutulumun nasıl tarif edileceğini biliyorum.
- [ ] Bir nodülü boyut, yoğunluk, sınır ve lokalizasyonla tanımlayabiliyorum.
- [ ] Buzlu cam ile konsolidasyonun farkını açıklayabiliyorum.
- [ ] Her toraks BT'de üç pencereye de baktığımı takip ediyorum.

HAFTA 6

# Batın BT

Akut batında sık nedenler ve kontrast fazlarının doğru kullanımı.

**Haftanın hedefi**

Batın BT'de organ organ sabit sırayla ilerlemek; apandisit, divertikülit, obstrüksiyon, serbest hava, taş ve travmaya bağlı organ yaralanmasını tanımak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Kontrast fazları (arteriyel, portal venöz, gecikmiş) ve tarama sırası. | Cilt 03 · BT |
| **Sal** | 30–45 dk | Apandisit ve divertikülit. Vaka 44. | En Sık Bulgular Atlası · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Barsak obstrüksiyonu ve pnömoperitoneum. Vaka 45. | Cilt 03 · BT |
| **Per** | 30–45 dk | Üreter taşı, pankreatit, kolesistit. Vaka 46. | Cilt 03 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cum** | 30–45 dk | Travmada solid organ yaralanması; karaciğer lezyonlarının dili. Vaka 47. | Cilt 03 · Görüntünün Alfabesi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 48, öz değerlendirme, batın BT rapor kalıbı. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 44 · Vaka 45 · Vaka 46 · Vaka 47 · Vaka 48

## Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Tetkikin hangi kontrast fazında çekildiğini ilk adımda belirliyorum.
- [ ] Batın BT tarama sıramı organ organ sayabiliyorum.
- [ ] Serbest havayı uygun pencerede aramayı alışkanlık hâline getirdim.
- [ ] Apandisit ve divertikülitte raporda yer alması gereken bulguları yazabiliyorum.
- [ ] Acil bulguyu sorumlu hekime ve uzman hocama bildirmem gerektiğini sonuç cümleme ekliyorum.

HAFTA 7

# Beyin ve omurga MR

Sekansları tanıyıp her birinin neyi gösterdiğini bilmek.

**Haftanın hedefi**

T1, T2, FLAIR, DAG ve kontrastlı serileri tanımak; akut enfarkt, demiyelinizan plak, kitle ve kord basısını tanımlamak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Sekansları tanıma: sıvı, yağ ve kanın sinyali. | Cilt 04 · MR · Cilt 01 · Fiziksel Alfabe |
| **Sal** | 30–45 dk | DAG ve akut enfarkt. Vaka 52. | Cilt 04 · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Beyaz cevher lezyonları ve MS plakları. Vaka 53. | En Sık Bulgular Atlası |
| **Per** | 30–45 dk | Kitleler: aksiyel ve ekstraaksiyel ayrımı, kontrastlanma. Vaka 54. | Cilt 04 · Görüntünün Alfabesi |
| **Cum** | 30–45 dk | Omurga: disk hernisi ve kord basısı. Vaka 55. | Cilt 04 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 56, öz değerlendirme, MR rapor kalıbı. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 52 · Vaka 53 · Vaka 54 · Vaka 55 · Vaka 56

## Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Bir seriyi açtığımda hangi sekans olduğunu sıvının sinyalinden anlayabiliyorum.
- [ ] DAG'da kısıtlanmayı ADC haritasıyla birlikte değerlendirmem gerektiğini biliyorum.
- [ ] Aksiyel ve ekstraaksiyel kitleyi ayıran bulguları sayabiliyorum.
- [ ] Kord basısının acil bildirilecek bir bulgu olduğunu ve nasıl tarif edileceğini biliyorum.
- [ ] MR'da «dansite» değil «sinyal» kelimesini kullanıyorum.

HAFTA 8

# Kas-iskelet ve batın MR

Diz ve omuz MR'ının temel okuma sırası; karaciğer ve hipofizde sık lezyonlar.

**Haftanın hedefi**

Diz ve omuz MR'ında bağ, menisküs ve tendonu sırayla değerlendirmek; karaciğerde sık görülen benign lezyonu ve hipofiz lezyonunu tanımlamak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Diz MR: normal anatomi ve sabit sıra. | Cilt 04 · MR |
| **Sal** | 30–45 dk | Ön çapraz bağ ve menisküs yırtıkları. Vaka 61. | En Sık Bulgular Atlası · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Omuz MR: rotator manşet. Vaka 62. | Cilt 04 · MR |
| **Per** | 30–45 dk | Karaciğer MR: hemanjiom ve kistin sinyal özellikleri. Vaka 63. | Cilt 04 · Görüntünün Alfabesi |
| **Cum** | 30–45 dk | Hipofiz ve sella bölgesi; beyin apsesi. Vaka 64. | Cilt 04 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 65, öz değerlendirme, kas-iskelet MR rapor cümleleri. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 61 · Vaka 62 · Vaka 63 · Vaka 64 · Vaka 65

### Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Diz MR'ında değerlendirdiğim yapıları sabit sırayla sayabiliyorum.
- [ ] Menisküs yırtığını düşündüren sinyal değişikliğini tarif edebiliyorum.
- [ ] Rotator manşet tendonlarını adlarıyla sayabiliyorum.
- [ ] Karaciğerde kist ve hemanjiomu ayıran temel MR özelliklerini açıklayabiliyorum.
- [ ] Emin olmadığım MR bulgusunu ayırıcı tanı ve öneriyle yazıyorum, kesin tanı gibi değil.

HAFTA 9

# Batın ve yüzeyel USG

Prob elinizdeyken sabit sıra: her organı iki düzlemde görün.

**Haftanın hedefi**

Karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve yüzeyel organlarda sistematik tarama yapmak; safra taşı, kolesistit, hidronefroz, kist ve nodülü doğru terimlerle tanımlamak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Prob seçimi, ayarlar, iki düzlem kuralı ve tarama sırası. | Cilt 05 · USG/POCUS |
| **Sal** | 30–45 dk | Karaciğer: hepatosteatoz, kist, apse. Vaka 70. | Cilt 05 · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Safra kesesi: taş, kolesistit. Vaka 71. | En Sık Bulgular Atlası |
| **Per** | 30–45 dk | Böbrekler: hidronefroz, basit kist. Vaka 72. | Cilt 05 · Görüntünün Alfabesi |
| **Cum** | 30–45 dk | Yüzeyel: tiroid nodülü, meme kisti; apandisit USG. Vaka 73. | Cilt 05 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 74, öz değerlendirme, USG rapor kalıbı. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 70 · Vaka 71 · Vaka 72 · Vaka 73 · Vaka 74

## Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Her organı iki düzlemde değerlendirip raporuma ekliyorum.
- [ ] Basit kistin USG kriterlerini sayabiliyorum.
- [ ] Safra taşını polipten ayıran bulguları (gölge, hareket) açıklayabiliyorum.
- [ ] Hidronefrozu tanımlarken kontralateral böbreği de değerlendiriyorum.
- [ ] USG'de «ekojenite» terimlerini doğru kullanıyorum.

HAFTA 10

# Doppler ve POCUS

Damar ve acil yatak başı USG: hızlı, odaklı, aynı sırayla.

**Haftanın hedefi**

Renkli Doppler'in temel mantığını kavramak; DVT, testis torsiyonu ve aort anevrizmasını tanımak; eFAST ve akciğer USG'sini (A ve B çizgileri) sabit sırayla yapmak.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Doppler temelleri: renk, akım yönü, sık artefaktlar. | Cilt 05 · USG/POCUS · Cilt 01 · Fiziksel Alfabe |
| **Sal** | 30–45 dk | Alt ekstremite venöz Doppler ve DVT. Vaka 78. | Cilt 05 · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Skrotal Doppler ve torsiyon; abdominal aort. Vaka 79. | En Sık Bulgular Atlası |
| **Per** | 30–45 dk | eFAST: pencereler ve serbest sıvı. Vaka 80. | Cilt 05 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cum** | 30–45 dk | Akciğer USG, perikardiyal efüzyon, ektopik gebelik şüphesi. Vaka 81. | Cilt 05 · USG/POCUS |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 82, öz değerlendirme, POCUS kısa rapor cümleleri. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 78 · Vaka 79 · Vaka 80 · Vaka 81 · Vaka 82

## Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] DVT değerlendirmesinde kompresibiliteyi temel bulgu olarak kullanıyorum.
- [ ] Testis torsiyonu şüphesinin acil bildirim gerektirdiğini biliyorum.
- [ ] eFAST pencerelerini sırayla sayabiliyorum.
- [ ] A çizgisi ile B çizgisinin ne anlama geldiğini açıklayabiliyorum.
- [ ] Negatif bir POCUS'un her zaman patolojiyi dışlamadığını raporumda belirtiyorum.

HAFTA 11

# Çoklu modalite ve acil

Aynı hastada grafi, BT, MR ve USG'yi birleştirmek; nöbet senaryoları.

**Haftanın hedefi**

Bir klinik soruya hangi tetkikin uygun olduğunu tartışabilmek; farklı modalitelerdeki bulguları tek bir sonuç cümlesinde birleştirmek ve acil bulguyu zamanında bildirmek.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Klinik sorudan tetkike: modalite seçimi mantığı. | Cilt 06 · Çoklu Modalite Vakaları |
| **Sal** | 30–45 dk | Travma hastası: grafi, eFAST ve BT birlikte. Vaka 87. | Cilt 06 · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | Nörolojik acil: BT'den MR'a. Vaka 88. | Cilt 06 · Çoklu Modalite Vakaları |
| **Per** | 30–45 dk | Akut batın: USG'den BT'ye. Vaka 89. | Cilt 06 · En Sık Bulgular Atlası |
| **Cum** | 30–45 dk | Göğüs ağrısı ve nefes darlığı senaryoları. Vaka 90. | Cilt 06 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Vaka 91, öz değerlendirme, acil bildirim cümleleri. | Pratik Defteri |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 87 · Vaka 88 · Vaka 89 · Vaka 90 · Vaka 91

### Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Bir vakada önceki tetkikleri ve diğer modaliteleri karşılaştırmayı unutmuyorum.
- [ ] Farklı modalitelerdeki bulguları tek bir sonuç cümlesinde toplayabiliyorum.
- [ ] Nöbette acil bildirmem gereken bulguların listesini söyleyebiliyorum.
- [ ] Emin olmadığım durumda uzman hocama danışmayı ve bunu kaydetmeyi alışkanlık edindim.
- [ ] Önerim klinik soruya doğrudan cevap veriyor.

HAFTA 12

# Genel tekrar ve vizit simülasyonu

On iki haftanın özeti: her vakayı vizitte sunar gibi anlatın.

**Haftanın hedefi**

Tüm modalitelerde 4 adımı otomatik uygulamak; bir vakayı 60 saniyede, sabit yapıda ve net bir sonuç cümlesiyle sunabilmek.

| GÜN | SÜRE | GÖREV | MATERYAL |
|---|---|---|---|
| **Pzt** | 30–45 dk | Röntgen tekrarı: defterdeki notlarınız; Vaka 96. | Cilt 02 · Pratik Defteri · 100 Pratik Vaka |
| **Sal** | 30–45 dk | BT tekrarı; Vaka 97 sesli sunum. | Cilt 03 · 100 Pratik Vaka |
| **Çar** | 30–45 dk | MR tekrarı; Vaka 98 sesli sunum. | Cilt 04 · Görüntünün Alfabesi |
| **Per** | 30–45 dk | USG ve POCUS tekrarı; Vaka 99. | Cilt 05 · En Sık Bulgular Atlası |
| **Cum** | 30–45 dk | Vizit simülasyonu: süre tutarak çoklu modalite vakası. Vaka 100. | Cilt 06 · Görüntü Yorumlama Rehberi |
| **Cmt** | 30–45 dk | Öz değerlendirme; ikinci dönem planınızı yazın. | Pratik Defteri · Haftalık İlerleme Takip Kâğıdı |

## Bu haftanın 5 vakası (100 Pratik Vaka)

Vaka 96 · Vaka 97 · Vaka 98 · Vaka 99 · Vaka 100

### Hafta sonu öz değerlendirme

- [ ] Her modalitede tarama sıramı kâğıda bakmadan söyleyebiliyorum.
- [ ] Bir vakayı 60 saniyede, sabit yapıda sunabiliyorum.
- [ ] Sonuç cümlem, ayırıcı tanım ve önerim her vakada yer alıyor.
- [ ] Zorlandığım konuları belirledim ve ikinci dönemin ilk haftalarına yerleştirdim.
- [ ] Çözmediğim 100 Pratik Vaka numaralarını ikinci tur için listeledim.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

# Sonraki adım

**Bugün Cilt 01 · Fiziksel Alfabe'yi açın ve Hafta 1'in Pazartesi görevine başlayın.** İlk 30 dakika, yılın geri kalanının ritmini belirler.

Vizitlere hazırlanmak için her haftanın konusuna denk gelen soruları **300 Vizit ve Sözlü Sınav Sorusu**'nda çalışın; ilerlemenizi **Haftalık İlerleme Takip Kâğıdı**'na işaretleyin.